intersex
NIGERIA
CENTER FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT & YOUTH EMPOWERMENT

VISIBILITÉ, INCLUSION ET RECONNAISSANCE DES PERSONNES INTERSEXES AU CAMEROON

(Une étude de base sur la Perception Publique de Personnes Intersexes et Mutilation Génitales au Cameroon).



By Intersex Nigeria
(Centre for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Informations sur les contacts

Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

Lagos and Abuja, Nigeria

info@intersexnigeria.org

+2349129057794

Visit notre site web

www.intersexnigeria.org

Média Sociaux

@Intersex_nigeria_

@IntersexNigeria

@IntersexNigeria

Intersex Nigeria

Publié par: Intersex Nigeria
Droits d'auteur: Intersex Nigeria, 2024



Date de publication: October, 2024

© Intersex Nigeria

REMERCIEMENTS

Profonde gratitude et appréciation à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette étude de base intitulée "Visibilité, Inclusion et Reconnaissance des Personnes Intersexes au Cameroon". Ce rapport de recherche est un témoignage du dévouement et de la collaboration de nombreux individus et organisations qui ont rendu cela possible. Nous remercions **Femme Debout** qui a gracieusement accueilli ce projet et veillé à la réalisation de ce rapport de recherche. Votre soutien à la communauté intersexe du Cameroon est tout à fait louable. Nous apprécions également la communauté intersexe du Cameroon dont la volonté de partager leurs expériences, leurs défis et leurs aspirations a été cruciale pour la réalisation de cette étude. Votre résilience et votre détermination nous appellent à poursuivre la lutte pour la libération, en ne laissant personne derrière. Nous remercions les participants à la recherche qui ont généreusement offert leur temps et leurs idées, ce qui nous a permis d'acquérir une compréhension globale des problèmes rencontrés par les personnes intersexuées au Cameroon. Votre confiance et votre collaboration ont contribué à mettre à jour les multiples facettes de cette recherche.

Nous remercions les consultants **Larissa Kojoué, PhD,** et **Theo Dongmo**, qui ont travaillé sans relâche pour sensibiliser le public aux questions intersexes au Cameroon. Votre dévouement à cette cause est louable et votre soutien à la diffusion de cette recherche est inestimable. Bien que nous aspirions à plus de connaissances et de compréhension du paysage des variations intersexes, nous remercions la communauté universitaire et de recherche pour son travail. Vos contributions ont ajouté de la profondeur et de la crédibilité aux résultats présentés dans ce rapport. Enfin, nous remercions **l'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA),** dont le soutien financier a rendu cette recherche possible. Votre engagement à faire progresser les droits et le bien-être des personnes intersexuées au Cameroon est profondément apprécié.

En conclusion, nous apprécions le travail incroyable du **Web Haptic Intelligence Group.** Nous remercions **David Benson** pour sa remarquable contribution éditoriale à ce rapport. Et nous exprimons notre immense gratitude à **Loé Petit** pour avoir soigneusement et minutieusement relecture et traduit l'étude de recherche du français vers l'anglais afin d'en conserver le contexte et l'authenticité. Nous sommes convaincus que cette étude sera un catalyseur de changement positif, conduisant à une visibilité, une inclusion et une reconnaissance accrues des personnes intersexuées au Cameroon et au-delà.

AVANT-PROPOS

Nous tenons à préciser d'entrée avoir conscience de notre connaissance très partielle de la question intersexe au moment de la mise en place de cette recherche. Bien que militantEs dans le cadre des droits sexuels et reproductifs en tant que féministes queer, la question intersexe nous apparaissait distante et éloignée de nos réalités. Il n'a pas non plus été possible d'inclure dans l'équipe une personne intersexe dont le vécu, la vision et l'approche auraient permis de mieux structurer l'enquête.

A l'occasion de cette enquête, nous avons pu déconstruire un grand nombre d'idées reçues et continuons d'être en phase d'apprentissage. Il est donc possible que la manière dont certains termes ou expressions soient utilisés ne fassent pas consensus auprès des associations militant pour le respect des droits des personnes intersexes. Nous présentons par avance nos excuses et vous prions de lire ce rapport en gardant à l'esprit l'humilité qui convient à des non spécialistes.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements		I
Avant-propos		II
Table Des Matières		III
1	**Introduction**	1
1.1	Contexte de l'étude	2
1.2	Objectifs de l'étude	3
2	**Méthodologie**	4
2.1	Limites	5
3	**Resultats De L'analyse**	6
3.1	**Etat Des Lieux De La Situation Des Personnes Intersexes Au Cameroon**	6
3.1.1	Entre vide juridique et abus. L'absence d'un cadre légal	6
3.1.2	Un milieu médical mal informé et peu formé	8
3.1.3	Silence, honte, rejet, stigmatisation, discrimination: une expérience sociale partagée	10
3.2)	**Perception Et Mythes Des Personnes Intersexes Au Cameroon**	14
3.2.1	Typologie des répondantEs	14
3.2.2	L'expression intersexe est-elle familière au vocabulaire cameroonais?	16
3.2.3	Entre mythes, croyances populaires et réalité	18
3.2.4	Des perceptions liées à l'intersexuation	20
3.3	Prevalence Des Mutilations Genitales Sur Les Personnes Intersexes Au Cameroon	23
3.3.1	Un acte chirurgical banalisé VS une violence non intégrée	23
3.3.2	Les mutilations génitales, une réalité pour 1 personne sur 3	25
3.3.3	Les mutilations génitales chez les personnes intersexes, ses risques et conséquences	25
4	**Conclusion**	27
5	**Recommendation**	28
	References	29

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet VIRAL (Projet initié par Intersex Nigéria) pour lutter contre les mutilations génitales faites aux personnes Intersexes au Cameroon et au Nigéria, une recherche exploratoire a été conduite sur la situation des personnes intersexes au Cameroon. Ce rapport fait état des éléments mis en lumière pendant la recherche exploratoire et va s'articuler autour de trois principaux axes:

- L'état des lieux de la situation des personnes intersexes ; Il s'agit de donner un aperçu de l'état des lieux des aspects juridiques, médicaux et sociologiques des personnes intersexes au Cameroon. Il se structure en quatre parties. La première présente le contexte ainsi que les objectifs et la méthodologie ; la seconde présente les aspects juridiques, la troisième présente les aspects médicaux et la dernière présente les aspects sociologiques.

- Les perceptions et mythes des personnes intersexes au Cameroon ; il s'agit ici de développer les idées que la population se font des personnes intersexes et comment ces impressions impacts la vies des personnes intersexes elles-mêmes.

- La prévalence des mutilations génitales sur les personnes intersexes au Cameroon. Une enquête qui exige non seulement une logistique adaptée, mais aussi des connaissances fines en épidémiologie, ce qu'aucun des chercheurs de ce projet ne possède. Etudier la prévalence d'un phénomène, c'est mesurer la fréquence de ce phénomène à un moment donné, sur une zone géographique donnée et sur une population donnée. Cela suppose d'avoir un minimum d'informations pour chaque individu pour une période donnée.

Il se trouve qu'en l'absence d'informations précises sur les registres de naissance au Cameroon (la Banque mondiale estime que seul 40% des naissances sont enregistrées) et en l'absence de documentations sur les personnes intersexes au Cameroon, nous ne pouvons que compter sur les expériences croisées des professionnels de santé et des personnes intersexes elles-mêmes. Par mutilations génitales nous entendons toute intervention visant la modification des organes génitaux, qu'elle ait lieu dans un cadre médicalisé ou non. De fait, le présent rapport ne donne qu'un aperçu très vague des mutilations génitales sur les personnes intersexes. D'une part parce que les opérations qui sont pratiquées sur les bébés nés avec des variations de sexe ne sont pas perçues comme des atteintes à l'intégrité physique, et d'autre part parce que nous avons rencontré peu de personnes pouvant témoigner de ces opérations.

1.1 Contexte de l'étude

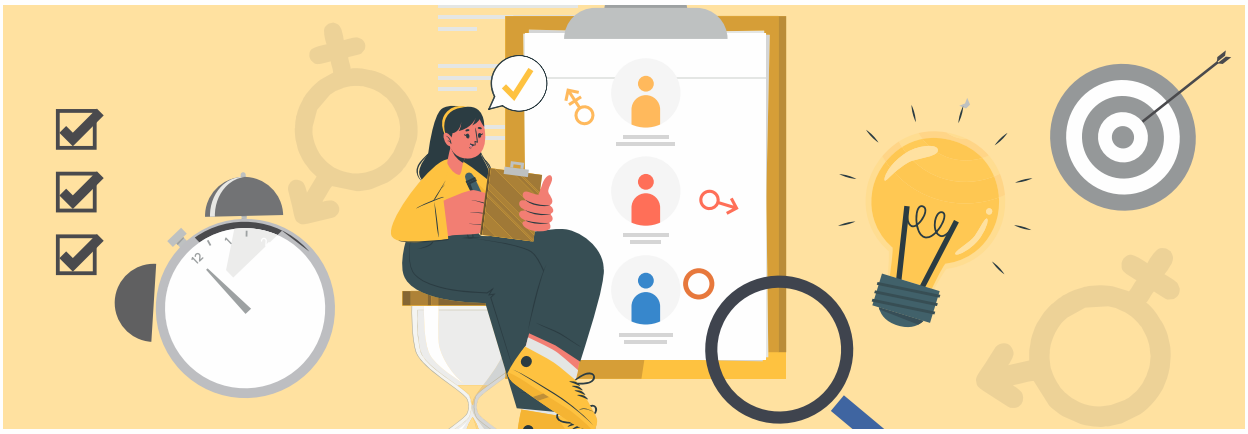


La binarité du sexe et des genres en hommes et femmes apparaît comme un invariant dans presque toutes les sociétés humaines. Toutes les personnes qui s'éloignent de ce schéma sont rejetées à la marge de la société et ostracisées. Ceux et celles qui présentent des caractéristiques sexuelles atypiques dès la naissance ou à l'adolescence sont communément mais improprement appelées "hermaphrodites". Ce terme spécifique aux plantes et aux animaux est souvent utilisé pour désigner les personnes qui présentent un développement des parties génitales assez atypique, voire ambigu, c'est-à-dire des variations génétiques, chromosomiques, anatomiques, gonadiques ou hormonales qui ne coïncident pas avec la catégorisation classique mâle ou femelle, masculin ou féminin. D'après les experts, un peu moins de 2% de la population mondiale naît avec des caractères intersexués. Dans les pays où les interventions médicales sont très avancées et les soins accessibles, il est très courant de faire subir aux enfants nés avec ces caractéristiques, des opérations chirurgicales ou d'autres interventions et traitements dans le but " d'harmoniser " leur sexe et leur apparence pour les rendre conforme aux normes de la binarité.

Au Cameroon, il existe très peu de documentation sur la question intersexe. En dehors de quelques cas rapportés par les médias sous forme de faits-divers où domine l'embarras, la violence et souvent beaucoup de douleur1, il est difficile de trouver des informations sur les personnes intersexes. Il n'est par exemple pas possible de savoir combien d'enfants naissent avec cette particularité, ni quel est leur vécu, de la petite enfance à l'âge adulte. Il existe de nombreux mythes et idées fausses sur ce que sontles personnes dites intersexes, ce qui rend le sujet tabou et toute recherche difficile.

C'est pour combler ce vide que cette recherche est menée.

1.2 Objectifs de l'étude



Avoir une idée précise de la situation des personnes intersexes au Cameroon, tant au plan juridique, au plan médical qu'au plan social.

Recueillir et analyser les différentes perceptions des personnes intersexes dans la société camerounaise.

Dresser un état des lieux des dispositifs et outils existants dans l'accompagnement des personnes intersexes.

Avoir une vision précise des acteurs, structures ou partenaires travaillant avec les personnes intersexes ainsi que la propension des mutilations génitales et leurs risques et conséquences.

c- Méthodologie



Pour atteindre ces objectifs nous avons fait le choix d'une méthodologie mixte combinant approche qualitative et approche quantitative.

L'approche quantitative a consisté à mesurer par questionnaire l'état des connaissances sur les personnes intersexes. Deux questionnaires distincts ont été administrés dont un s'adressant en particulier aux professionnels de santé et un autre à la population générale. Les critères de participation étaient relativement ouverts, ce qui a permis la participation de près de 1000 répondantEs, répartiEs dans toutes les grandes villes du Cameroon. L'ensemble des questionnaires a été administré en face à face. Les données recueillies par questionnaires ont été traitées par Excel. Ces données feront l'objet d'un rapport séparé portant sur les mythes et les perceptions des personnes intersexes au Cameroon.

L'approche qualitative a consisté en: une revue documentaire des différents textes et publications portant ou concernant directement ou indirectement les personnes intersexes au Cameroon; des entretiens individuels avec des profils très divers comprenant à la fois des personnes intersexes, leurs proches ou parents, des médecins, des journalistes, des autorités administratives et légales comme des juristes, des avocats ou des policiers; et enfin deux rencontres collectives (en cours) don't la première va être une discussion ouverte entre ces différents acteurs autour de la situation des intersexes au Cameroon.

La seconde rencontre sera la présentation des résultats et la validation du rapport en présence des personnes ayant activement participé à cette recherche.

Les données qualitatives ont été traitées de manière classique en prenant soin de noter des faits saillants, des récits de vie et des points de récurrence et de croisement entre différentes données. Nous utilisons ainsi beaucoup de verbatim inspirés des entretiens pour illustrer nos analyses.

De façon plus spécifique, pour avoir les résultats sur la prévalence des mutilations génitales, notre travail repose sur un matériau composite. Des données ont été extraites d'une enquête

quantitative portant sur l'état des connaissances et la perception des personnes intersexes ; Nous avons spécifiquement extrait les données des personnels

de santé et des tradi-praticiens. Par ailleurs, d'autres données plus qualitatives ont été collectées à partir des entretiens avec ces mêmes professionnels (médecine hospitalière et traditionnelle); ainsi que d'entretiens avec des personnes intersexes elles -mêmes.

d- Limites

Nous avons identifié plusieurs limites.

Au plan méthodologique, l'échantillon de la population enquêtée n'est pas suffisamment représentatif d'une population de plus de 25 millions d'habitants.

Cependant, vu qu'il s'agit d'une enquête exploratoire menée dans les dix régions du pays, et vu qu'il s'agit d'une question encore méconnue du grand public, les données recueillies peuvent servir d'outils de plaidoyer. Par ailleurs, la question intersexe étant nouvelle, du moins en ces termes spécifiques, le fait pour les enquêteurs d'expliquer d'emblée de quoi il s'agit a biaisé l'analyse sur l'état des connaissances.

Par exemple, avant d'administrer le questionnaire, l'enquêteur devait expliquer de quoi il s'agissait. De fait à la question de savoir si oui ou non le ou la repondant.e avait déjà entendu parler du terme intersexe, la réponse était oui.

Il n'a pas été facile de mobiliser les personnes intersexes elles-mêmes dans cette enquête ; il s'agit peut-être d'un défaut de communication ; il est aussi possible cependant que le temps court consacré à l'enquête ainsi que les moyens mis à disposition n'aient pas été suffisants.

Une autre limite est liée aux capacités de l'équipe, notamment en matière de statistiques. Ainsi il n'a pas été possible de conduire une étude spécifique pour déterminer la prévalence des mutilations génitales sur les personnes intersexes comme le projet l'aurait souhaité.

Il est néanmoins possible d'évaluer l'ampleur des interventions chirurgicales sur les personnes intersexes par les professionnels de santé.

3 RESULTATS DE L'ANALYSE

3.1 ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES PERSONNES INTERSEXES AU CAMEROON



3.1.1 Entre vide juridique et abus. L'absence d'un cadre légal

La loi camerounaise est muette sur le phénomène de l'intersexuation. Lorsqu'un enfant né avec des variations sexuelles difficiles à classer comme de sexe masculin ou féminin, les parents et les agents d'état civil choisissent en général d'inscrire l'un ou l'autre sexe pour la forme, bien que rien ne laisse penser que cet enfant développerait les caractéristiques associées au genre féminin ou masculin. Dans certains cas rares, par exemple là où il est courant de ne pas enregistrer les enfants dès la naissance mais plus tard, l'acte de naissance n'est simplement pas établi. Il existe ainsi des enfants intersexes privés d'acte de naissance alors qu'il s'agit d'une pièce importante, d'un droit fondamental dont découle plusieurs autres droits. Sans acte de naissance en effet, il n'est pas possible d'être reconnu par l'Etat. Il n'est pas possible d'accéder aux services de base comme l'éducation, comme la santé, comme la justice.

C'est la situation vécue par Claude, née Rosalie. La loi ne prévoit pas la reconnaissance d'un sexe autre que féminin ou masculin. Il a dépassé la trentaine, n'a pas de pièce d'identité et n'a jamais pu obtenir de pièce officielle parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. Or Claude présente les deux caractéristiques et en dépit des nombreuses explications des conditions de sa naissance, ce droit fondamental ne lui est pas reconnu.

Pour les personnes intersexes dont l'acte de naissance a été établi et mentionne un sexe qui finalement est contredit par le développement de l'enfant à l'adolescence et ou à l'âge adulte, seule une décision du juge permet la rectification des mentions de sexe.
La rectification du nom ressort de la décision du Président de la République.

C'est l'ORDONNANCE N° 81/002 du 29 JUIN 1951 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques qui organise l'établissement des actes de naissance, de mariage et de décès. Qu'il s'agisse de la rectification d'une mention sur un acte de naissance ou de la reconstitution d'un acte de naissance lorsque celui-ci n'a pas été établi dans les 60 premiers jours de vie d'un enfant, il faut une décision du juge. Au Cameroon, la reconstitution de l'acte de naissance a lieu en cas de perte, destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pas pu être effectuée auprès de l'officier d'état civil dans le délai de soixante jours suivant l'accouchement par le chef de l'établissement hospitalier ou le médecin lorsque l'enfant est né à l'hôpital ou par toute autre personne qui a assisté la mère dudit enfant ou plus tard par les parents de l'enfant. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans les six mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal compétent sous certaines conditions.

C'est un jugement qui permet d'obtenir reconstitution ou rectification de l'acte de naissance. Cette procédure est peu utilisée étant donné la lourdeur des conditions, la lenteur des procédures et le coût.

En conséquence, les personnes intersexes utilisent des actes de naissance qui sont soit falsifiés, soit faux et illégaux. Si cette solution temporaire permet d'accéder à certains services, elle reste précaire et non durable sur le long terme. Il n'est par exemple pas possible de se présenter à des concours officiels, d'obtenir un passeport, d'ouvrir un compte en banque, etc. Autant de droits fondamentaux auxquels les personnes intersexes n'ont pas accès faute de reconnaissance légale de leur existence.

Pour celles et ceux qui ont effectivement un acte de naissance et une pièce d'identité, c'est souvent au moment du renouvellement de ces pièces que se posent les problèmes. Certains agents exigent une décision du juge lorsque l'apparence ne correspond pas au sexe indiqué sur l'acte de naissance, et soumettent très souvent les demandeurs de ce service public à des traitements humiliants et dégradants comme exiger de voir les parties intimes, ou poser publiquement des questions indiscrètes.

Les agents de l'Etat, tout comme le reste de la société s'avèrent non informéEs et très mal forméEs sur le cas des personnes intersexes. Claude a été arrêté par la police à plusieurs reprises et poursuivi au Tribunal par un Procureur qui lui reprochait une usurpation d'identité.

3.1.2 Un milieu médical mal informé et peu formé

Les résultats de notre étude exploratoire auprès des professionnels de santé et assimilés, qu'il s'agisse de médecins (gynécologues, chirurgiens, pédiatres, psychologues), d'experts en santé publique, d'aides-soignantE, d'infirmiers, de sagefemmes, de sexologues, de pharmaciens, ainsi que des étudiants en médecine, etc.

montrent que sur 188 personnes interrogées, 134 ont déjà entendu parler du terme "intersexe", soit un taux de connaissance du phénomène de 71%. En revanche, bien qu'ayant entendu parler du terme intersexe, beaucoup continuent à utiliser le terme " hermaphrodite ", et 23% ont une connaissance erronée de ce qu'est une personne intersexe. Ils confondent en premier avec la transidentité, et ensuite avec l'homosexualité. 14% de ces professionnels pensent qu'il faut absolument opérer dès la naissance en fonction du sexe dominant, tandis qu'environ 30% pensent qu'il faut les laisser choisir une fois adolescent ou adulte avant d'opérer. Cependant, pour plus de 50% il faut laisser les personnes intersexes en l'état, vu les conséquences que peuvent avoir les opérations, et au lieu d'opérer, proposer un accompagnement psychologique.

Deux personnes parmi les professionnels de santé ont tout de même estimé qu'il fallait les bannir. Le Cameroon n'échappe donc pas à la pathologisation de l'identité intersexuée. Dans l'enquête destinée aux professionnels de santé, plus de la moitié estime qu'il s'agit d'une malformation (à corriger). Dans la majorité des cas, des opérations sont pratiquées sur les nouveaux nés et parfois à l'adolescence, sans urgence ni nécessité médicale sérieuse (ces enfants sont en bonne santé et leurs organes fonctionnent parfaitement), avec non seulement des risques de complication (aucune opération médicale est non invasive et bénigne) et des conséquences physiologiques et psychiques parfois dramatiques. Lorsque les organes affectés fonctionnent mal par exemple ou lorsque une fois adultes, ces enfants ne développent pas les caractéristiques souhaitées. Clarisse (surnom) a aujourd'hui 28 ans, elle n'a jamais eu ses règles, et ses seins ne se sont jamais développés.

Dans son cas, ses parents avaient choisi l'ablation de son pénis. Ces opérations apparaissent comme "allant de soi" pour certains professionnels de santé qui estiment qu'il faut à tout prix assigner aux personnes intersexes, une binarité légale et sociale de genre.

Claude explique avoir lui-même été opéré quand il avait 3 mois. Il en garde encore le souvenir car ses cicatrices l'ont longtemps fait souffrir. C'est faute de moyens que ses parents n'ont pas poursuivi les autres opérations qui étaient prévues. On a pu avoir des télmoignages de 4 cas de mutilation génitale des personnes Intersexe, cependant nous n'avons pas pu accéder aux souches. Il s'agissait principalement des personnes encore mineures qui présentaient des ambiguïtés génitales visibles. Les familles ont décidé pour deux d'entre elles d'opérer leurs enfants afin qu'elles soient des "filles" et les deux autres des "garçons". Malheureusement, à

l'adolescence, les "garçons" ont commencé à avoir des poussées mammaires et les "filles" n'ont jamais eu des seins, encore moins des menstruations.

Pour autant, ce sont les parents qui parfois insistent pour qu'une opération soit pratiquée sous la pression des normes sociales. *"J'ai déjà vu un cas comme ça. La famille voulait détruire un sexe. On les a conseillés mais ils ont insisté et on a fait l'opération" déclare une infirmière.*

Il s'avère que les professionnels de santé n'ont pas souvent la formation, ni les connaissances nécessaires leur permettant de tenir compte des besoins de santé des personnes intersexes.

Dans la société camerounaise les soins sont dispensés par deux grandes catégories de personne, le personnel médical et assimilé dont on vient de parler, et les tradipraticiens.

Une grande partie de la population confie leur soin à cette deuxième catégorie et la recherche a montré que sur 26 tradipraticienNes ayant déjà été en contact avec des personnes intersexes, 21 ont déclaré avoir déjà entendu parlé des personnes intersexes, soit 77.7%. Cependant aucunE n'a pu définir correctement le terme, 8 ont déclaré que c'étaient des personnes ayant 2 sexes, 5 ont estimé qu'il s'agissait des personnes présentant des anomalies au niveau de leur sexe, ou qui développaient des caractères sexuels secondaires contraire à leur sexe "exemple, une femme qui a la barbe". Une personne a déclaré que les personnes intersexe n'existait pas, 4 tradipraticienNes sont convaincuEs que ce sont des personnes qui sont attirées par les hommes et les femmes à la fois.

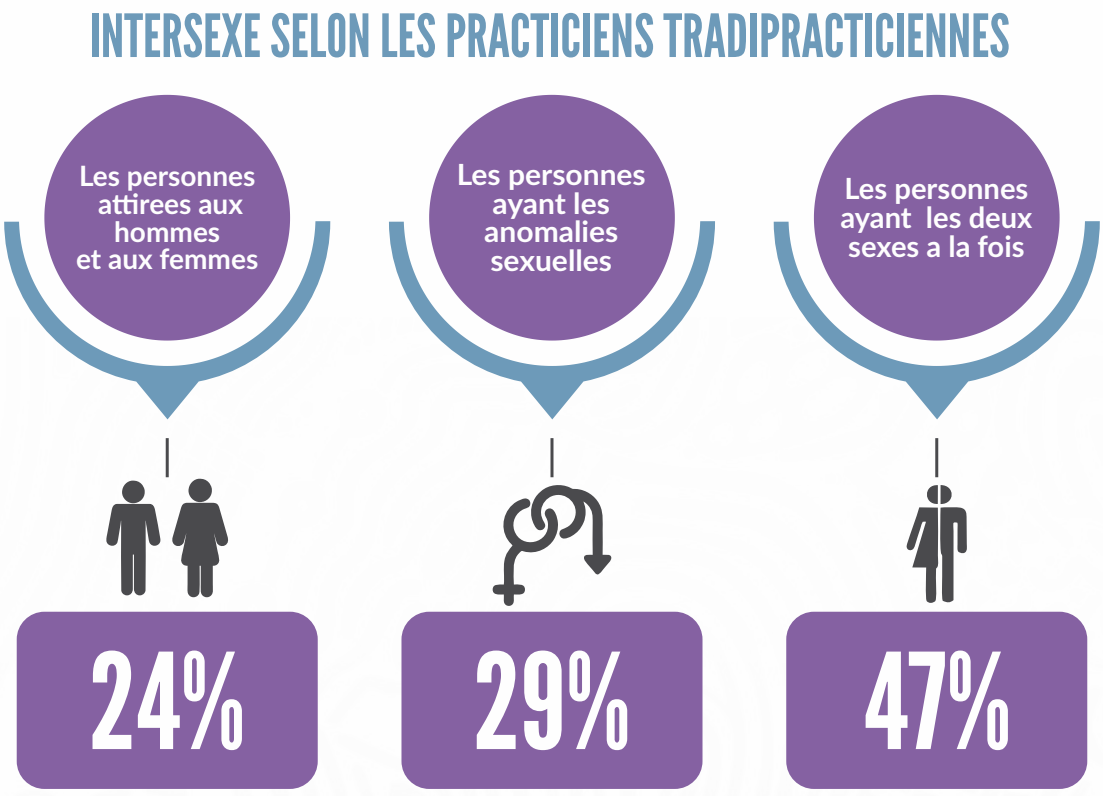


Figure 1

75% des personnes qui n'ont jamais entendu l'expression intersexe pense que ce sont des personnes attirées par les hommes et les femmes, tandis qu'une personne pense que "c'est un homme qui a un vagin", aussi 75% de ces personnes ont déjà entendu l'expression hermaphrodite.

50% les tradipraticienNes rencontrés déclarent avoir déjà consulté des cas de personnes intersexes. Les avis sont mitigés, la grande majorité a été contacté par des parents qui souhaitaient que leur enfant soit délivré de ce qu'ils croyaient être un maléfice, si certains ont en effet conseillé de "tuer un des sexes", la plupart ont dit que c'était dangereux de le faire et ont conseillé aux familles de laisser les enfants grandir et faire leur propre choix. Cependant une personne a jugé qu'il était mieux de "les exterminer".

3.1.3 Silence, honte, rejet, stigmatisation, discrimination: une expérience sociale partagée

Ce qui caractérise socialement les personnes intersexes au Cameroon, c'est surtout une expérience partagée de silence, de honte, de rejet, de stigmatisation et de discrimination.

Lorsqu'une personne nait, la première question est souvent de savoir quel est le sexe de l'enfant. Avec la difficulté de distinguer le sexe de l'enfant commence les premiers silences de la part des parents. Les bébés sont ainsi l'objet de curiosité dès les premiers mois de leur vie. Claude explique que dans son cas sa maman évitait de le confier aux autres femmes pour le bain contrairement aux pratiques traditionnelles. Pourtant la nouvelle s'est vite répandue. Jouer avec d'autres enfants était devenu difficile du fait de la méfiance créée par les parents : *"On m'appelait boy-girl et beaucoup disaient que je n'étais pas normal et qu'il ne fallait pas jouer avec moi. Ce qui fait que je restais dans mon coin"*. Les parents n'ont pas souvent les ressources pour expliquer l'identité de leur enfant. Et lorsqu'ils ne fréquentent pas assidûment les médecins, les tradipraticienNEs ou les prêtres et pasteurs, ils choisissent de les cacher pour conjurer la honte.

Le silence est aussi institutionnel et commence par la difficulté à établir un acte de naissance. Il est aussi dans la difficulté à situer l'enfant, à lui donner un nom féminin ou masculin. Il se poursuit tout au long de l'existence, à l'hôpital notamment, mais aussi à l'école, sur le lieu de travail, etc. *"Moi j'ai compris que j'étais différent vers 6 ou 7 ans alors que les autres enfants se moquaient de moi lorsqu'on se lavait. Mes parents m'habillaient en fille mais j'avais une bosse dans le caleçon comme les garçons (...) Vers 8 ans j'ai commencé à m'habiller comme un garçon. C'était mieux comme ça (...) C'est vers 25 ans que j'ai pris les choses en main, je suis moi-même allé chez un* gynécologue. J'avais besoin de comprendre. *C'est là qu'on a enfin pris le temps de m'expliquer que j'étais une femme sans utérus. J'ai*

l'apparence d'un homme mais mes seins se sont développés du coup mes neveux m'appellent tantine" (LC, 32 ans) Lorsqu'on demande à la population générale si elles pensent que les personnes intersexes sont normales, 52% estiment que oui, 24% estiment que non, et environ 3% n'ont aucune idée. 335 personnes connaissent2 au moins une personne intersexe, soit environ 35%. C'est dans cette proportion qu'on retrouve le plus de personnes qui pensent qu'il s'agit de personnes normales (208, soit plus de 62%). Cependant, y compris chez ceux et celles qui connaissent ou ont déjà rencontré une personne intersexe 120 estiment qu'elles ne sont pas normales, soit environ 36%.

Table 1. Crossed knowledge of intersex people and perception

	OUI	NON
Connaissez-vous des personne intersexe ?	335	577
	YES	**NO**
Les personnes intersexes sont: Normales	208	269
Pas normales	120	292
Ne sait pas	7	16
Do not know		

Les données de l'enquête par entretien contrastent avec les récits de vie des personnes intersexes que nous avons recueillis. Elles laissent penser que la majorité de la population est au courant de ce qu'est une personne intersexe, et du fait que ces

dernières devraient être traitées comme tout citoyen, dans le respect de ses droits. Pourtant pour l'ensemble des témoignages reçus, c'est un véritable parcours de rejet et de discrimination tout au long de la vie: *"Les piques ça ne manque jamais. La famille, les passants. Tout le monde se permet de faire des remarques" (JM, 36 ans); "On m'insulte toujours même aujourd'hui ce n'est pas facile. Les petits enfants se moquent de moi quand je passe. Ils disent regarde le père là avec la barbe et les seins comme une femme";* LC, 37 ans; *"S'entendre traiter de malédiction ou de sorcellerie voir de déchet de la société alors qu'on n'a pas choisi de naitre comme ça c'est vraiment lourd. Les gens disent qu'on détruit la société. Que nous sommes une abomination. C'est dur"* (JM).

Toutes les personnes intersexes avec qui nous nous sommes entretenues racontent des expériences traumatisantes à l'école, mais surtout avec la police. Elles sont contrôlées et humiliées lorsque leur apparence ne correspond pas au sexe inscrit sur peur pièce d'identité lorsqu'elles en ont, ce qui ouvre la porte à toutes sortes d'abus. "Ce qui m'embête le plus c'est la police. Ils nous martyrisent au lieu de comprendre explique JM, tout ça parce qu'ils veulent de l'argent".

Aucune des personnes intersexes interrogées n'a de diplôme universitaire, ni de diplôme secondaire. Si certains ont dû arrêter l'école pour se protéger des moqueries, d'autres ont fait d'autres choix, motivés soit par leur passion comme c'est le cas de JM qui aurait voulu devenir footballeuse professionnelle, mais dont la carrière n'a pas décollé suite aux nombreuses humiliations lors des tests.

Au plan religieux, sur les 30 hommes et femmes exerçant un métier lié aux religions abrahamiques (pasteur, prêtre, imam), 27 ont déjà entendu parler des personnes naissant avec les caractéristiques des deux sexes, bien qu'ils et elles ne savent comment définir une personne intersexe. Parmi elles, 11 personnes, soit 36% pensent que les personnes intersexes ne sont pas normales. C'est une proportion importante au sein du milieu religieux, et cela montre toute l'ampleur de la méconnaissance de cette question.

Tableau 2: Récapitulatif des informations sur le vécu des personnes intersexes

	Acte de naissance	Pièce d'identité	Scolarité	Situation professionnelle	Situation familiale	Arrestation police	Opération
JM	Oui	Oui	Primaire	Secteur informel	vit en famille	Oui	Non
Claude	Non	Non	Primaire	Secteur informel	Père de deux enfants	Oui	Oui (à 3 mois)
LC	Oui	Oui	Primaire	Secteur informel	Vit seul	Oui	Non

Nous soulignons une fois de plus une grande difficulté à rencontrer les personnes Intersexes, la grande majorité vivant une vie cachée, ceux et celles que nous avons pu rencontrer et écouté sont des victimes/survivantEs de violence dont l'identité sexuelle a été rendu publique indépendamment de leur volonté, et a été empreint de violence, de rejet et aujourd'hui ils/elles ont le sentiment de n'avoir plus rien à perdre.

Pourquoi autant de mystère sur une particularité qui finalement est intrinsèque à la nature d'une minorité d'êtres humains ?

Quelles sont les mythes et perceptions qui entourent les personnes intersexes au Cameroon ?

3.2 PERCEPTION ET MYTHES DES PERSONNES INTERSEXES AU CAMEROON



3.2.1 Typologie des répondantes

Cette recherche exploratoire a permis de mettre en lumière les idées que les populations se font des personnes intersexes. La recherche exploratoire a permis de toucher 1013 personnes répartie en plusieurs catégories à travers le territoire Cameroonais, le genre, les tranches d'âges, les catégories socio-professionnelles.Cette répartition c'étend sur 9 des 10 régions que compte le Cameroon :

Les personnes qui ont été questionnées ont ainsi constituées l'échantillon de base de cette recherche exploratoire et font partie de plusieurs catégories socioprofessionnelles que nous avons regroupé dans les grandes catégories suivantes :
- Professionnels de santé cadre (les médecins et spécialistes)
- Professionnels de santé non cadre (infirmiers, nutritionnistes, psychologues, etc.)
- Guérisseurs, Tradipracticiens et naturopathes
- Religieux
- Etudiants
- Enseignants
- Juristes (avocat et para légal)
- Sans emploi
- Secteur informel
- Corps armé
- Médias
- Travailleurs.ses sociaux.iales

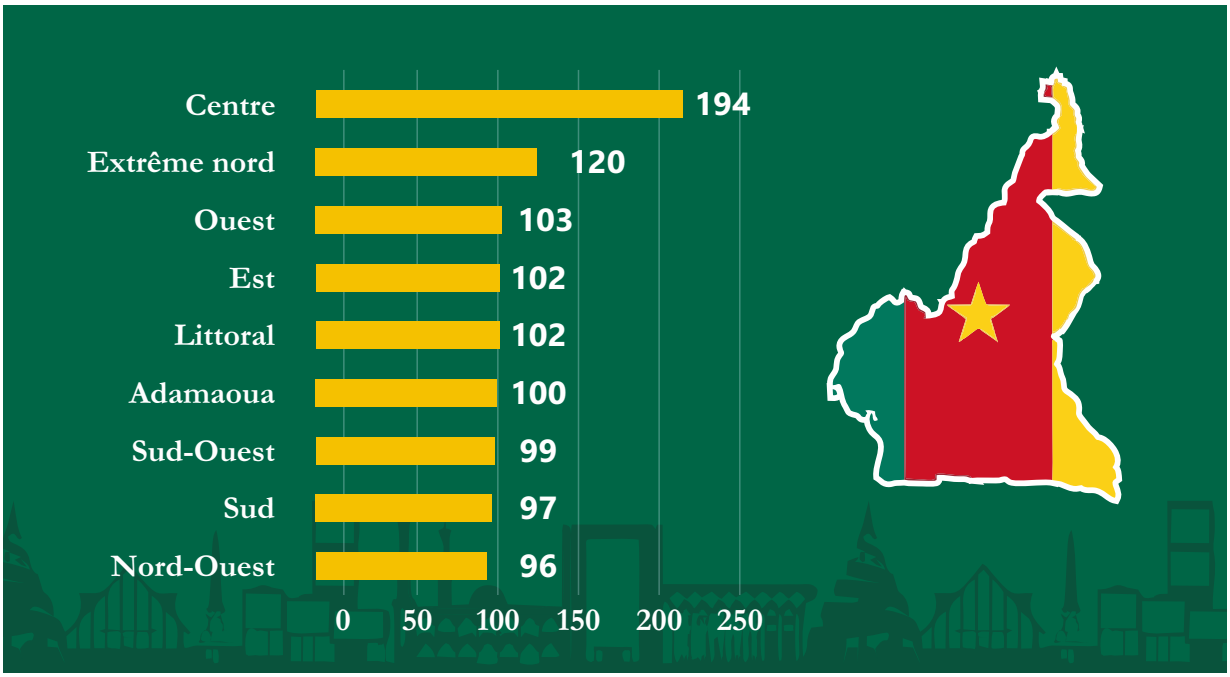


Figure 2

En plus de ces catégories socio-professionnelles, les répondantEs font partie des tranches d'âge assez variés compris entre 15 et 70 ans. Nous avons réparti les âges par tranche, 15-20 ; 21-30 ; 31-40 ; 41-50 ; 51-60 ; 61-70.

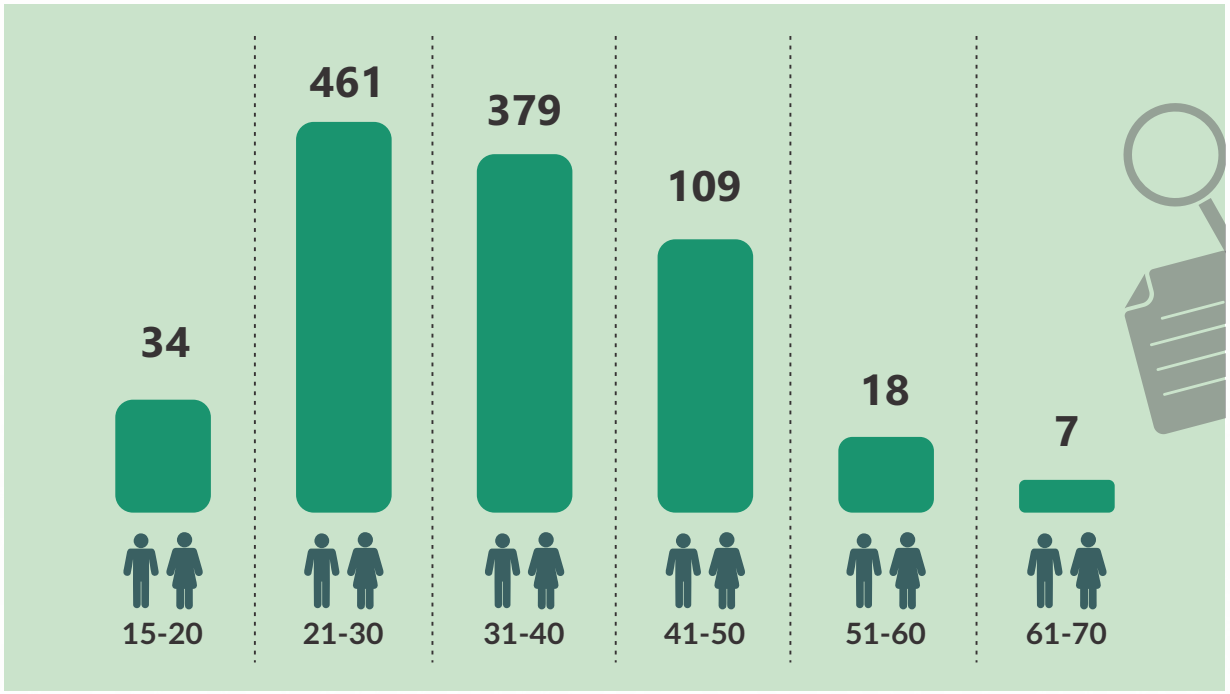


Figure 3

Nous avons pu constater que les tranches d'âge qui ont le plus participé à la recherche sont les 21-40 ans.

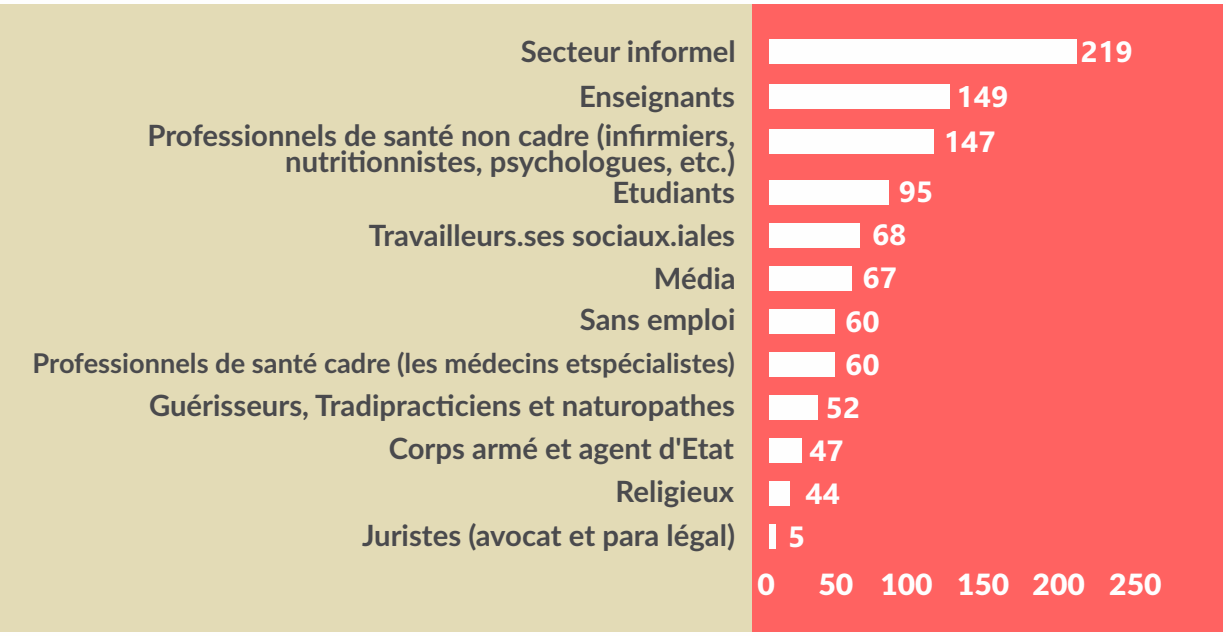


Figure 4

Nous avons pu constater que les tranches d'âge qui ont le plus participé à la recherche sont les 21-40 ans.

I.2 L'expression intersexe est-elle familière au vocabulaire camerounais ?

Pour répondre à cette interrogation, nous avons posé une série de 03 questions à l'échantillon.

I Avez-vous déjà entendu parler des personnes intersexes ?

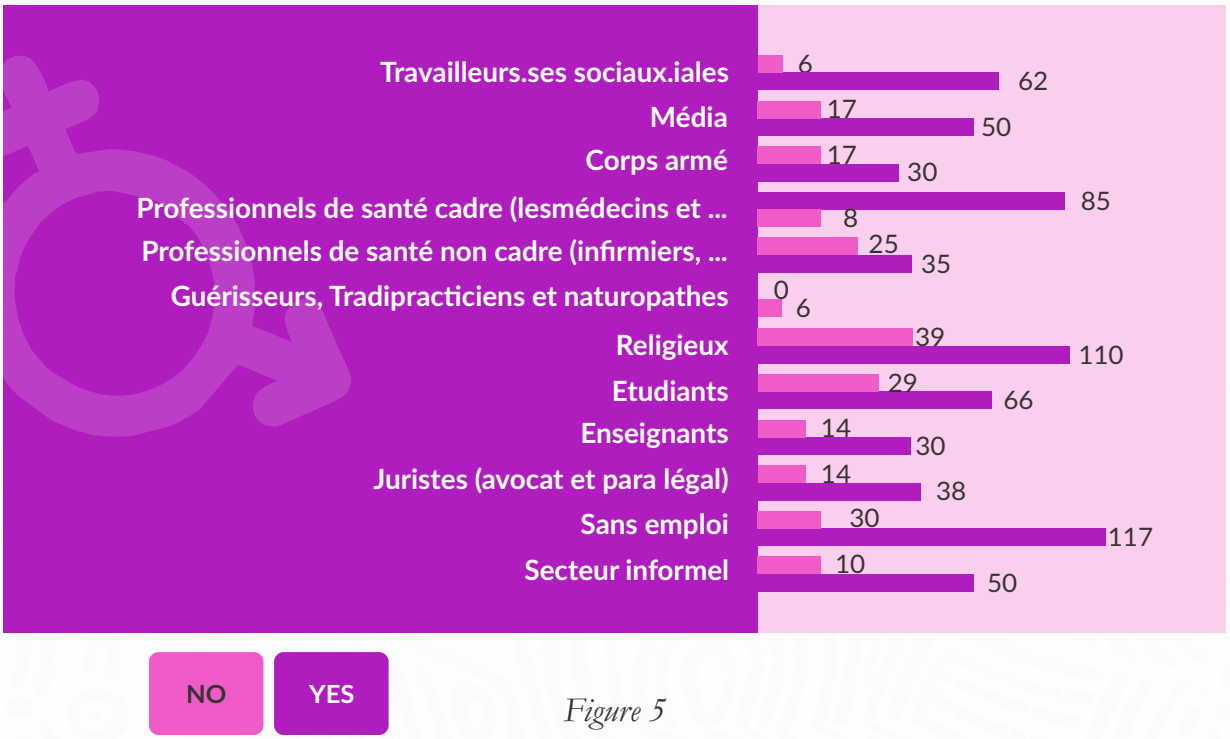


Figure 5

De façon global 39.33% des personnes interrogées n'ont jamais entendu l'expression intersexes. Est-ce que les 60.7% des personnes qui en ont entendu parler savent réellement de quoi il s'agit ?

III Avez-vous déjà entendu parler des personnes dites hermaphrodites ?

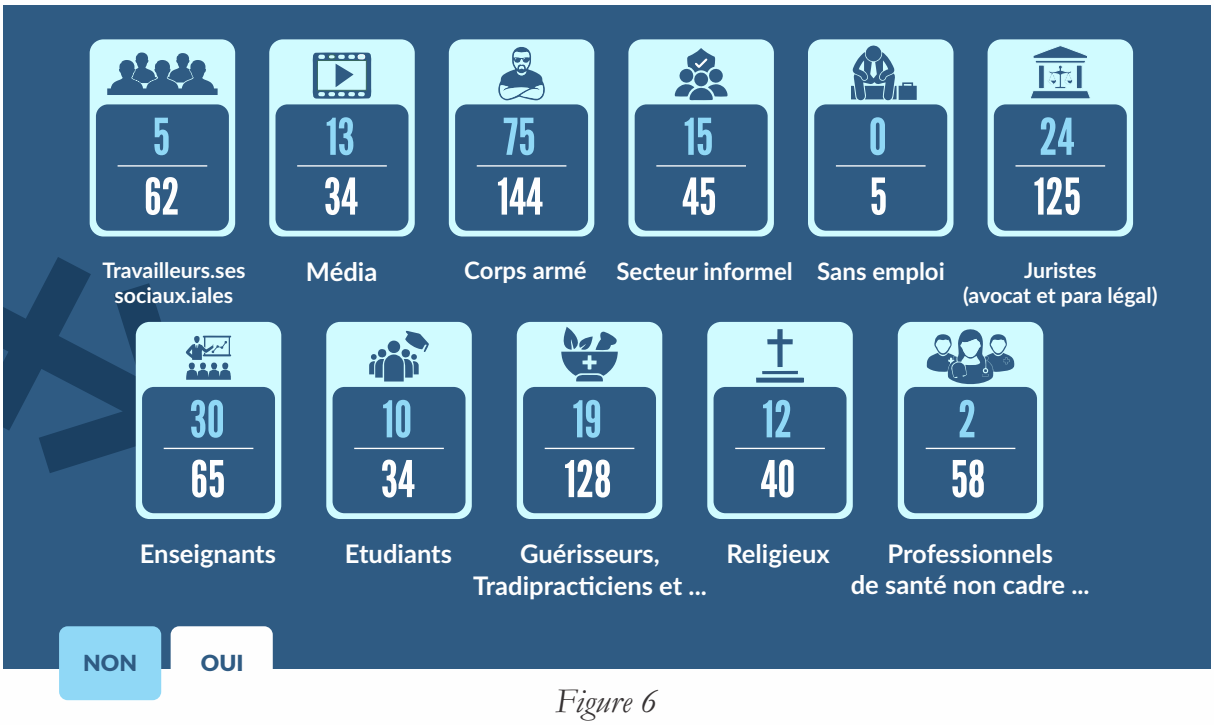


Figure 6

Ainsi 75 % des personnes interrogées ont déjà entendu parler des personnes dites hermaphrodites, soit 14.3% de plus que les personnes prétendant connaitre l'expression intersexe.

IV Avez-vous déjà entendu parler des personnes ayant deux sexes ?

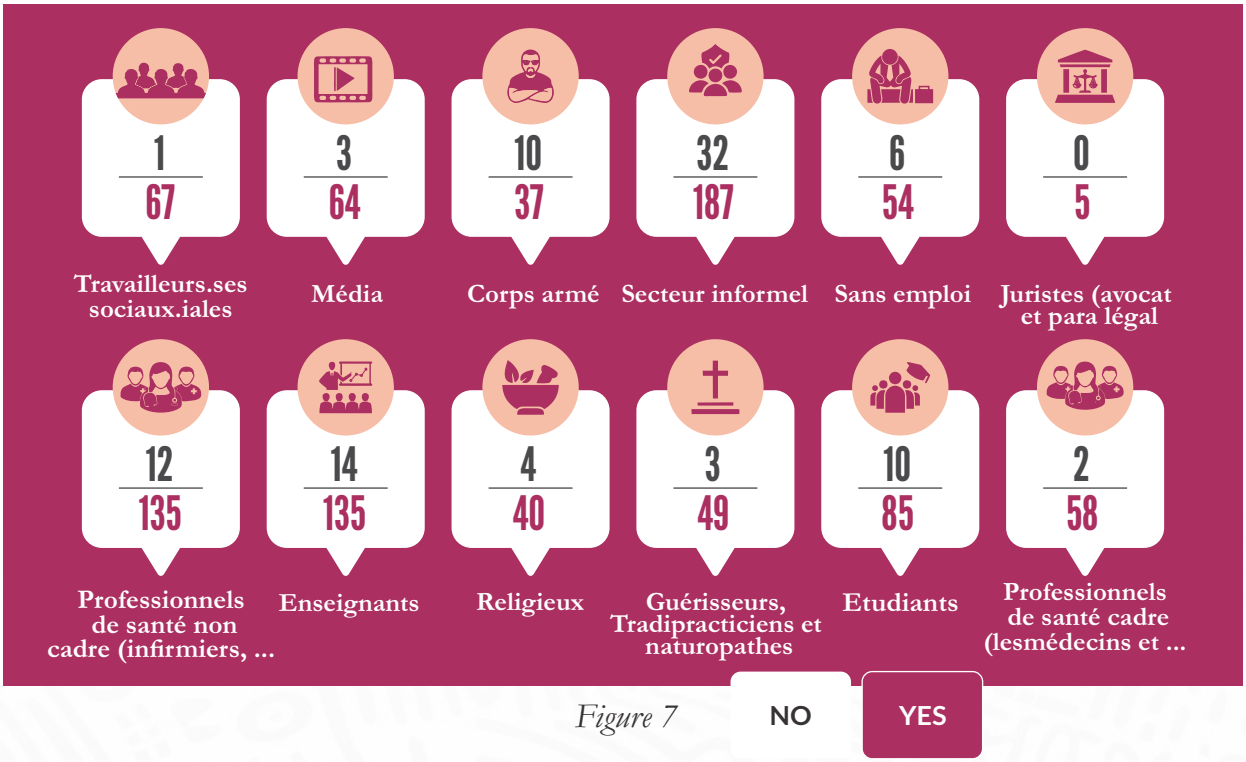


Figure 7

Vu les résultats de la recherche, 90% des CamerounaisEs interrogéEs sont plus proche de l'expression " personnes ayant deux sexes ", proportionnellement moins de personnes sont familières à l'expression hermaphrodites, et 30% de moins par l'expression " intersexe ".

Cette analyse nous a permis de comprendre que dans la compréhension des personnes interrogées, la perception des identités sexuelles reste très binaire. Soit on a un sexe (male/femelle), soit on en a deux en cas d'intersexuation. Encore que la notion d'intersexuation reste très mitigée au sein de la communauté Camerounaise, suivant le milieu socio-professionnel, la formation, la zone où l'on vie.

3.2.3 Entre mythes, croyances populaires et réalité

I De la définition de l'intersexuation par les camerounais



Pour avoir des réponses les plus proches de la réalité des questions ouvertes ont été posées sans orientations/propositions de réponses.

Ainsi nous avons plusieurs acceptions de l'expression intersexe, allant de personnes ayant deux sexes, à sorcierEs, homosexuelLes, nous avons rassemblés les définitions par catégories.

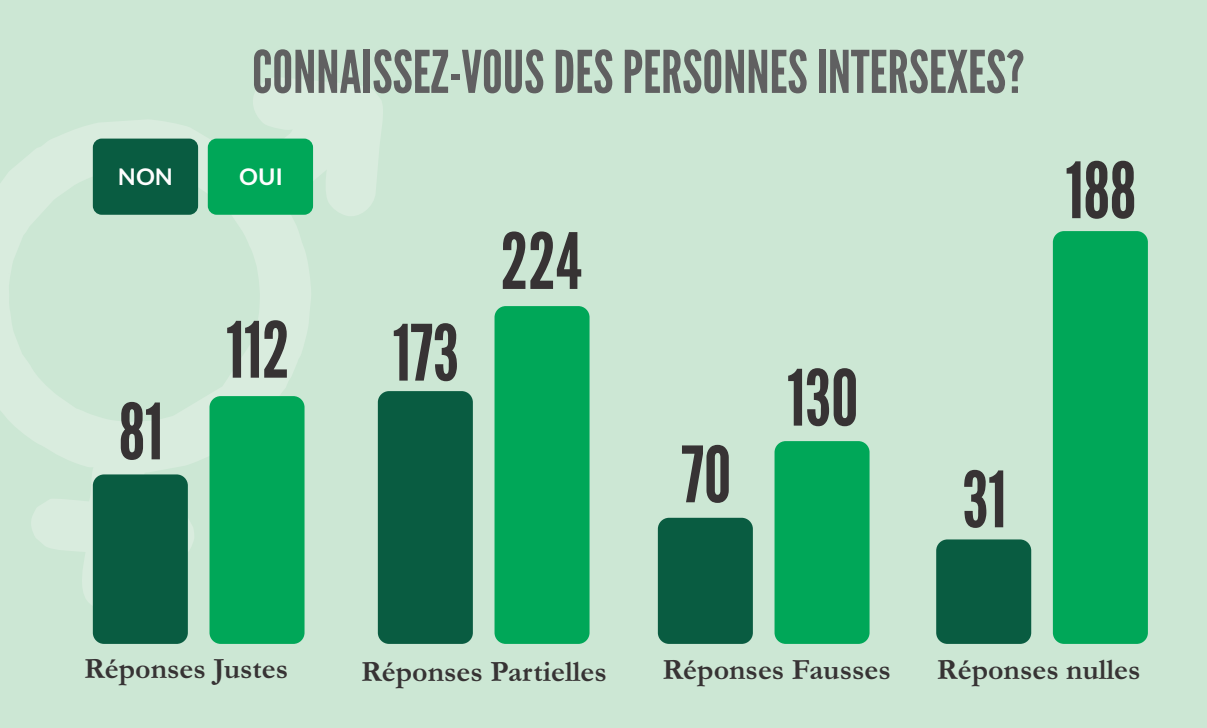
-Les réponses justes. Ce sont les réponses qui allaient dans le sens de la définition de l'intersexuation, soit selon l'ONU comme "une manière de décrire les caractères sexuels biologiques d'un individu, notamment ses organes génitaux, ses gonades, ses taux d'hormones et ses chromosomes" lorsque ces caractères ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou féminin. Comme exemple de réponse juste on pouvait avoir : Une personne qui a les deux caractéristiques sexuelles, dont les caractères ne correspondent pas aux normes ; qui présente les caractéristiques féminins et masculins, etc.
- Les Réponses partielles, Exemple : une personne qui n'est ni homme ni femme ; mal formation congénitale, etc.

- Les Réponses fausses, Exemple : un homosexuel, pas d'orientation sexuelle, sorcellerie etc.
- Les réponses nulles, ceux et celles qui ne savent pas.

Table 3

	Juste	Partielle	Fausse	Nulle
Professionnels de santé cadre (les médecins et spécialistes)	18	30	7	5
Professionnels de santé non cadre (infirmiers, nutritionnistes, psychologues etc.)	36	63	31	17
Guérisseurs, Tradipracticien Nes et naturopathes	9	22	12	9
Religieux	5	17	11	11
Etudiants	25	27	20	23
Enseignants	16	60	34	39
Juristes (avocat et para légal)	1	3	1	0
Sans emploi	4	23	19	14
Secteur informel	32	78	33	76
Corps armé	7	16	11	13
Média	16	27	14	10
Travailleurs.ses sociaux.iales	25	31	7	5

Seulement 23% des personnes prétendant connaitre, et avoir déjà été en contact avec des personnes intersexes ont la définition juste de l'intersexuation ou intersexualité.



Si on se focalise sur les personnes qui connaissent des personnes intersexes, et que nous avons plus de 75% de réponses partielles ou fausses, on comprend le mystère qui plane sur cette communauté.

D'après les interviews menées auprès des personnes intersexes, 65% se définissent comme étant des personnes ayant deux sexes, tandis que 35% se défini comme étant une personne Trans, ceux qui se définissent comme ayant 2 sexes ont essayé de se faire opérer pour conserver un seul sexe, et ce avec le concours des médecins.

3.2.4 Des perceptions liées à l'intersexuation

La recherche exploratoire a permis de classer les perceptions des répondant
Es en trois grandes catégories :

- Les perceptions négatives

- Les perceptions positives

- Les perceptions neutres

Les perceptions négatives font référence ici aux idées dévalorisantes, avilissantes que les personnes ont envers les personnes intersexes. Elles comprennent sans s'y limiter les idées selon lesquelles, ce sont des gages de malédictions, des êtres aux pouvoirs



Figure 9

mystiques, mais aussi des personnes homosexuelles3, des personnes ayant une sexualité débridée. Globalement que ce soit mystique ou scientifique, ici les personnes interrogées pensent que les personnes intersexes sont sources de déséquilibre dans l'ordre de la nature.

Pour comprendre les perceptions, et surtout leur impact dans la vie des personnes intersexes et leurs proches, nous avons demandé aux répondant ce qui devrait être fait pour les personnes intersexes. Entre malédiction et exorcisme, nous avons noté beaucoup d'empathie, d'écoute et de compréhension.

Age range	15-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
Malédiction, discrimination, marginalisation	4	27	11	4	0	0
Soutien, empathie, compréhension, écoute	9	195	180	45	10	0
Opération médicale	10	47	37	15	4	1
Exorcisme	0	9	7	2	1	0
Laisser vivre dans le respect	3	41	22	18	0	0
Information, formation de la société	2	28	3	0	1	0
RAS	6	111	102	22	3	2

On note 43% d'empathie, de compréhension et d'écoute, ce qui est une bonne base pour initier des sensibilisations, des plaidoyers et formations, afin d'améliorer non seulement la compréhension de l'intersexuation, mais aussi déconstruire les idées préconçues, qui ont impact négatif considérable sur les personnes intersexes.

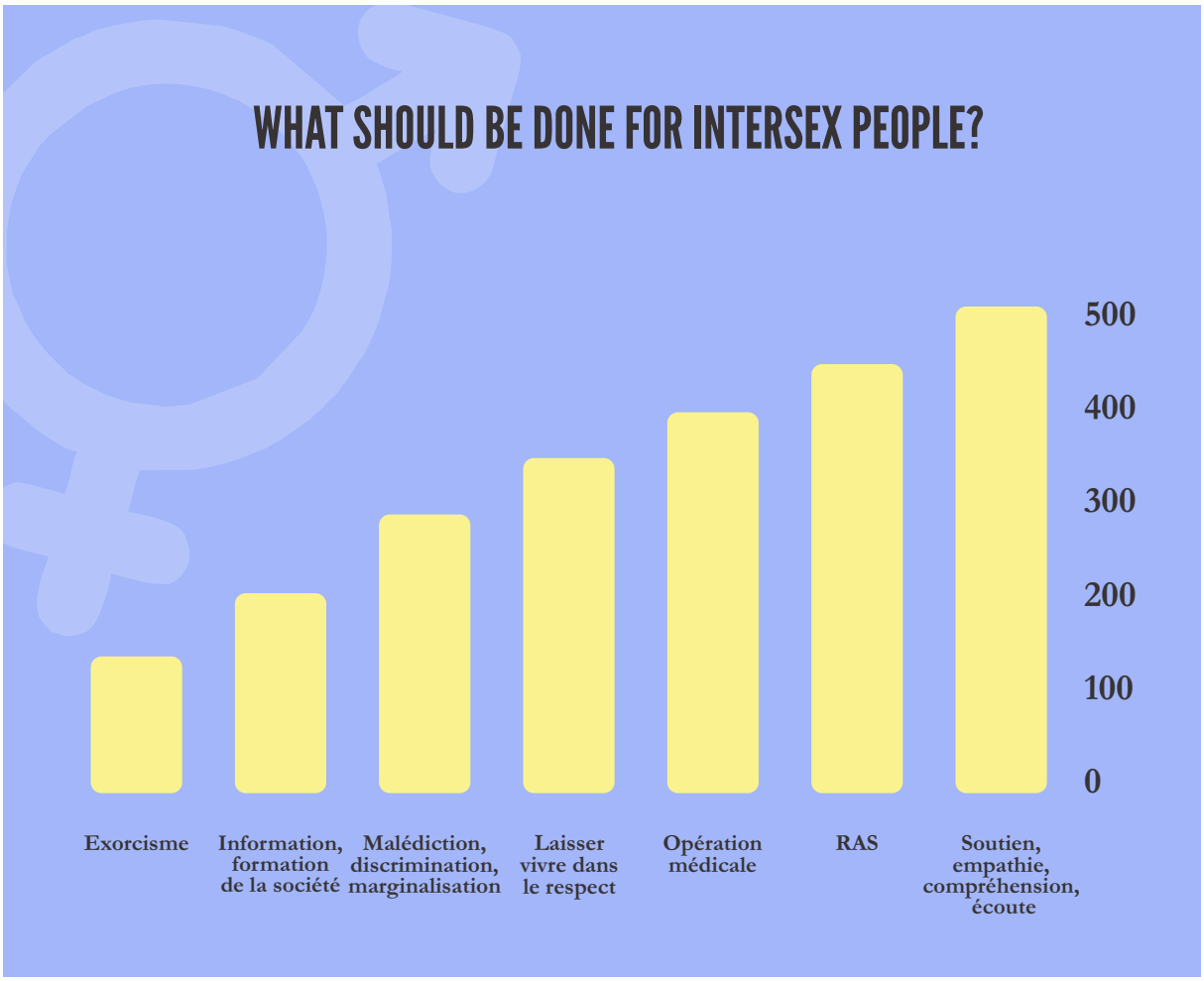


Figure 10

Même si les exorcismes, malédictions, et opérations médicales reste une proportion assez importante des avis récoltés (18%), ayant les informations liées aux tranches d'âges et catégories socio-professionnelles concernées, il sera plus aisé d'élaborer des outils de communications et sensibilisations adaptés.

Au-delà des mythes et des perceptions il est important de comprendre le phénomène des mutilations génitales faites aux personnes intersexes, leur récurrence et leurs effets et impact.

3.3 PREVALENCE DES MUTILATIONS GENITALES SUR LES PERSONNES INTERSEXES AU CAMEROON

3.3.1 Un acte chirurgical banalisé VS une violence non intégrée



Les résultats de notre étude exploratoire auprès des professionnels de santé et assimilés, qu'il s'agisse de médecins (gynécologues, chirurgiens, pédiatres, psychologues), d'experts en santé publique, d'aides-soignants, d'infirmiers, de sagefemmes, de sexologues, de pharmaciens, ainsi que des étudiants en médecine, etc.

montrent que 14% de ces professionnels pensent qu'il faut absolument opérer dès la naissance en fonction du sexe dominant, tandis qu'environ 30% pensent qu'il faut les laisser choisir une fois adolescent ou adulte avant d'opérer. Cela fait en tout 44% de professionnels de santé hospitalière qui estiment que l'opération est nécessaire.

L'étude a montré tout de même qu'il y a environ 50% de professionnels qui estiment qu'il faut laisser les personnes intersexes en l'état, vu les conséquences que peuvent avoir les opérations, et qu'au lieu d'opérer, proposer un accompagnement psychologique. Deux personnes parmi les professionnels de santé ont tout de même estimé qu'il fallait les bannir.
Sur ces 188 professionnels de santé, 60 sont des médecins et spécialistes. Parmi ces 60 professionnels 40 pensent que l'intersexuation est naturelle et d'une certaine façon normale. 31 estiment que les personnes intersexes ont besoin d'écoute et d'empathie, tandis que 4 pensent qu'il faut à tout prix une opération d'assignation d'un sexe. Environ 37% des médecins ont déjà reçu en consultation des personnes intersexes, dont 9 plus d'une fois, spécifiquement dans les villes de Yaoundé et Douala. 75% de ces professionnels estiment que l'intersexuation est une particularité à accepter.

Peu de médecins ont déclaré avoir opéré des enfants intersexes. Sur environ 25 des patients intersexes qu'il a consultés tout au long de sa carrière, un médecin chirurgien déclare avoir

opéré moins d'une dizaine, souvent avec l'insistance des parents, souvent du fait d'un défaut de fonctionnement des organes, comme pour faire pipi par exemple.
Toutes les opérations réalisées l'ont été sur des enfants, des nouveaux nés et des enfants de moins de 5 ans.

Il paraît évident que du côté du secteur médical les opérations ne semblent pas systématiques, quand bien même certains professionnels n'y voient pas forcément une violence, mais un acte chirurgical dit de réparation. Cela pose quand même quelques questions qui méritent d'être adressées. Que traduit le fait que peu de médecins y compris des pédiatres aient consulté des personnes intersexes ? Vu la proportion de professionnels qui ne trouve aucun inconvénient à pratiquer des opérations, pourquoi y en a-t-il si peu qui en parlent finalement ? Notre hypothèse est qu'il faut pousser la recherche et voir s'il s'agit d'une omerta entre professionnels, d'un problème d'accès aux services de santé ou d'un évitement volontaire des services de santé de la part des personnes concernées et/ou de leurs parents.

Du côté des tradipraticienNEs, aucune expérience de mutilation n'est reportée. Les entretiens révèlent que lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de cas, ce qui est très rare et est toujours le fait de parents, ils préfèrent référer les enfants vers l'hôpital si les parents souhaitent une chirurgie. Autrement, ils se contentent de proposer d'autres traitements pour améliorer la santé mentale et spirituelle de leurs patients. Il est difficile de confirmer cette information au stade actuel de l'enquête.

En effet 02 tradipraticienNes sur les 52 interrogés pensent qu'on devrait tuer les personnes intersexes à la naissance, 4 préconisent des traitements spirituels, pour exorciser le mauvais sort, la plupart du temps c'est la demande du parent, et 50% de ces dernierEs pensent que ces traitements traditionnels doivent pouvoir "tuer" un des sexes et permettre à l'enfant d'être plus épanouis. Si seulement 05 tradipraticienNes pensent clairement qu'il est important de faire une mutilation avec le concours du corps médical, les interviews ont donné une impression de non-dit. Les tradipratienNes écouté ont mis une emphase sur le fait qu'ils/elles ne sont pas habileté à faire ce type d'opération et que seuls les médecins étaient à même de le faire. Aucun des tradipraticienNes interrogé n'ont admis avoir fait une opération sur unE patientE intersexe. Comme recommandation, il serait important de faire un travail spécifique avec les tradipratitienNes, qui après le corps médical, ont été le plus en contact avec les personnes intersexes, 2 tradipraticienNe sur 3 ont déjà eu à être consulter sur le cas

d'une personne intersexe. Qu'en est-il des personnes intersexes elles-mêmes ?

III.2 Les mutilations génitales, une réalité pour 1 personne sur 3

Une personne sur les 3 personnes que nous avons interviewées déclare avoir subi une mutilation à 3 mois. Ces opérations auraient pu continuer si son père avait eu plus de moyens. Une personne sur trois c'est quand même une proportion importante, et c'est assez révélateur de l'ampleur des mutilations sur les personnes intersexes. Si les deux autres personnes intersexes n'ont pas été opérées, un médecin a déploré le fait que l'unE d'eux n'a pas pu être opéré à la naissance, les mutilations sont vraiment une réalité dans le vécu des enfants et adultes intersexes au Cameroon. Cette étude gagnerait à approfondir cette réflexion auprès des personnes intersexes elles-mêmes. Or l'une des difficultés majeures de cette recherche a principalement été de recueillir des témoignages de la part des personnes intersexes.

3.3.2 Les mutilations génitales chez les personnes intersexes, ses risques et conséquences

Lors de la recherche exploratoire, une grande partie de la population a défini une personne intersexe comme étant une personne ayant deux sexes. A ce titre, entre autres propositions faites, des personnes ont évoquées l'ablation de l'un des deux sexes soit par voix chirurgical, soit par voix mystiques, et ceci n'est pas sans conséquence, selon les médecins, les tradipraticienNes et les personnes intersexes



3.3.3 Conséquences médicales des mutilations génitales chez les personnes intersexes

Les personnes Intersexes subissent des opérations d'assignation sexuelle qui sont vécues comme des mutilations génitales et une atteinte à leur intégrité physique et psychique. Cette mutilation se fait par des interventions chirurgicales et l'administration de médicaments Ces mutilations ne sont pas sans conséquences et parmi les conséquences médicales, nous pouvons citer :

Les conséquences immédiates :

- La douleur
- L'infection de la plaie opératoire,
- Une hémorragie

Les conséquences tardives sont :

- La modification des parties génitales externes et du système reproducteur
- Un traitement hormonal de substitution à vie est instauré chez certaines personnes. Ce traitement peut également accroitre les risques de maladies thrombo-emboliques,
- Une insensibilité au traitement hormonale notamment aux androgènes liés à un défaut de fonction du récepteur aux androgènes.
- Une hyperplasie congénitale des surrénales due à une limitation de production d'hormones dans les glandes surrénales. Ceci affecte la croissance et le développement de l'enfant. Non ou mal suivie, elle peut évoluer vers la mort
- Sur le plan sexuel, elles peuvent se traduire par une douleur lors des rapports sexuels suite à une mauvaise cicatrisation de la chirurgie sur les organes sexuels, une insensibilité érotique
- L'acte chirurgicale peut également avoir comme séquelle une fistule vésicourétrale qui se traduit par une incontinence urinaire.



II Conséquence socio-psychologiques

Nous avons pu rapporter les risques suivants :

- La paralysie complète ou partiel de la personne
- La stérilité

La mort

- L'ablation du " mauvais "sexe
- Les troubles sexuels (impuissances/frigidité)

Les conséquences les plus récurrentes étaient :

- Les problèmes d'ordres psychologiques
- L'inconfort physique d'être dans le mauvais corps
- L'inadaptabilité social
- Le fort besoin de se cacher et de cacher son corps, lié à l'incompréhension et l'inconfort.



CONCLUSION

Notre enquête montre que peu de professionnels déclarent avoir pratiqué des actes de réassignation de sexe sur les personnes intersexes, qu'il s'agisse des spécialistes de la médecine hospitalière ou de la médecine traditionnelle. Cependant une personne intersexe sur trois déclare avoir subi une opération à la naissance. Les mutilations sont certainement sous-estimées ainsi que leurs conséquences, du fait du manque de visibilité des personnes intersexes.

L'objectif de départ de cette enquête au Cameroon ne visait que de manière parallèle à mesurer la prévalence des mutilations génitales sur les personnes intersexes. C'est pourquoi la plupart des données s'appuient plus sur un état des lieux de la situation des personnes intersexes et des perceptions, que sur des données épidémiologiques.

Réaliser une étude de prévalence dans des conditions propres aux études épidémiologiques s'avère nécessaire.

En outre il n'est pas possible de savoir combien d'enfants naissent intersexuées au Cameroon. Premièrement parce que se pose encore des problèmes dans l'enregistrement des naissances. Le taux d'enregistrement des naissances pour les moins de 5 ans est d'environ 40% selon la Banque mondiale. Ensuite, l'obligation de mentionner un sexe F ou M pousse les parents à choisir un sexe pour leurs enfants nés avec des variations de sexe difficile à classer. Parfois les parents sont amenés à attendre pour voir quelles caractéristiques sexuelles domineront. Mais ce n'est pas toujours évident. Ensuite, passé le délai d'enregistrement légal de toute naissance qui est de 60 jours, il faut une décision du juge pour établir un acte de naissance. Une procédure longue et parfois coûteuse.

De fait, $^{1/3}$ des personnes intersexes interrogées n'ont pas de pièces d'identité, et aucune n'a une pièce d'identité conforme à son identité.

La plupart a à peine terminé le cycle primaire et vivent des métiers informels, ce qui ajoute à leur précarité. Bien que la majorité des médecins estiment qu'il est juste d'attendre que les personnes choisissent elles-mêmes la solution la mieux adaptée à leurs besoins, une partie importante préfère encore recourir ou recommandent des mutilations. Le degré de préjugés et d'idées reçues sur les personnes intersexes est particulièrement élevé et démontre l'ampleur du travail d'information, de formation et de communication autour du phénomène de l'intersexuation au Cameroon.

RECOMMENDATION

Pour les professionnels de la santé et les praticiens traditionnels



- Implémenter des programmes de formation obligatoire pour les professionnels de la santé y compris les médecins (les chirurgiens, les pédiatricians, les psychologues et les infirmières) sur l'intersexe, ces variations, et les considérations éthiques autour des interventions chirurgiques.
- Prioritiser les soutiens psychologiques pour les individus intersexes et leurs familles en ce qui concerne les interventions chirurgicales. Former les professionnels de la santé pour fournir des conseils non judgementaux et empathiques.
- Assurer que des interventions médicales soient menées avec l'autorisation des individus intersexes déjà à l'âge de maturité. Décourager des interventions chirurgicales fréquentes sauf dans le besoin médical.
- Établir les régulations claires et les protocoles pour la gestion de variations intersexes ainsi que la priorisation du bien-être.
- Faciliter la collaboration entre les praticiens traditionnels et les professionnels de la santé pour assurer que les individus intersexes reçoivent le soutien approprié et sont exclus de pratique dangereuses.
- Organiser les ateliers et les sessions informatiques pour les praticiens traditionnelles pour les éduquer sur l'évaluation Intersexes et les risques de mutilation génitale. Souligner l'importance référenciation médicale lorsque nécessaire.

Pour le Décideurs et Groupes de sensibilisation.



- Les lois qui protègent les individus intersexes des mutilations génitales non autorisées et qui assurent leur droits à l'autonomie intégrité corporelle.
- Améliorer un processus d'inscription de la naissance pour assurer la présentation adéquate des naissances intersexes ainsi qu' assurer la délivrance des pièces d'identités aux individus intersexes.
- Lancer des campagnes pour la sensibilisation publique en vue d'éduquer le public sur
les variations intersexes, ainsi que pour réduire les méconnaissances et stigmatisations.
- Établir des réseaux de soutien et ressources pour les individus intersexes et leurs familles pour fournir le soutien communautaire, l'information et l'orientation.

REFERENCES

1. Ammaturo, Francesca Romana. 2016. Intersexuality and the "Right to Bodily Integrity". *Social & Legal Studies* 25: 591–610.
2. Bauer M, Truffer D, Crocetti D (2020) Intersex human rights. *The International Journal of Human Rights* 24(6): 724–749.
3. Bauer, Markus, Daniela Truffer, and Daniela Crocetti. 2020. Intersex Human Rights. *International Journal of Human Rights* 24: 724–49.
4. Boladale, M., Olakunle, O., Olutayo, A., et al. (2015) Sexual Orientation and Quality of Life among Students of Obafemi Awolowo University (OAU), Nigeria. African Health Sciences, 15, 1065-1073. https://doi.org/10.4314/ahs.v15i4.3
5. Carpenter M (2012) Intersex: Intersectionalities with disabled people. Available at: https://ihra.org.au/21214/intersex-and-disability (accessed 29 June 2021).
6. Carpenter M (2016) The human rights of intersex people: Addressing harmful practices and rhetoric of change. *Reproductive Health Matters* 24(47): 74–84.
7. Carpenter M (2019) Joint Statement on the International Classification of Diseases 11. Available at: https://ihra.org.au/35299/joint-statement-icd-11/ (accessed 29 March 2022).
8. Carpenter M (2020) The OHCR background note on human rights violations against intersex people. *Sexual and Reproductive Health Matters* 28(1): 13–16.
9. Carpenter M (2020a) Intersex human rights, sexual orientation, gender identity, sex characteristics and the yogyakarta principles plus 10. *Culture, Health and Sexuality* 23(4): 516–532.
10. CoE (Council of Europe Commisioner for Human Rights). 2015. Human Rights and Intersex People. Issue Paper. Strasbourg. Available online: https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/6683-pdf-human-rights-and-intersex-people.html (accessed on 5 January 2023).
11. Crocetti, Daniela, Elisa A. G. Arfini, Surya Monro, and Tray Yeadon-Lee. 2020. "You're Basically Calling Doctors Torturers": Stakeholder Framing Issues around Naming Intersex Rights Claims as
12. Crocetti D, Monro S, Vecchietti V, et al. (2020) Towards an agency-based model of intersex, variations of sex characteristics (VSC) and DSD/DSD health. *Culture, Health and Sexuality* 23(4): 500–515.
13. Davis G (2015) *Contesting Intersex: The Dubious Diagnosis*. New York: New York University Press.
14. Davis, Georgiann. 2014. The Power in a Name: Diagnostic Terminology and Diverse Experiences. *Psychology and Sexuality* 5: 15–27.
15. Diamond M, Garland J (2014) Evidence regarding cosmetic and medically unnecessary surgery on infants. *Journal of Pediatric Urology* 10(1): 2–6.
16. Dickens B (2018) Management of intersex newborns: Legal and ethical developments. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 143(2): 255–259.
17. Dreger AD (1998) *Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex*. Cambridge: Harvard University Press.

18. Dreger AD (1999) *Intersex in the Age of Ethics. Hagerstown*. Maryland: University Publishing Group.
19. Dreger, Alice D., and April M. Herndon. 2009. Progress and Politics in the Intersex Rights Movement Feminist Theory in Action. *GLQ* 15: 199–200.
Ernesto Zelayandia-Gonzalez
20. , 2023, The Growing Visibility of Intersex Demands at the United Nations: A Review of the Treaty Bodies' Concluding Observations, Doctoral School in Humanities, Social Sciences and Law, University of Granada, 18071 Granada, Spain, *Soc. Sci. 12*(2), 73; https://doi.org/10.3390/socsci12020073
21. Essiben, F., Didjo, C., Koh, V.M., et al. (2019) Adolescent Sexual Behavior in an Urban Area of a Resource-Limited African Country, Cameroon. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 9, 923-935. https://doi.org/10.4236/ojog.2019.96090
22. ECHR (European Court of Human Rights). 2022. M v. France. Application no. 42821/18. Decision of the Fifth Section of 26 of April 2022. Strasbourg. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217430%22]} (accessed on 27 December 2022).
23. FRA (EU Agency for Fundamental Rights). 2015. *The Fundamental Rights Situation of Intersex People*. Vienna: FRA. Available online: https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people (accessed on 27 December 2022).
24. FRA (2015) The Fundamental Rights Situation of Intersex People. Report, FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, Austria, April.
25. FRA (2020) EU-LGBTI II: A Long Way to go for LGBTI Equality. Report, FRA-European Union Agency for Fundamental Rights. Austria, May.
26. Garland F, Travis M (2018) Legislating intersex equality: Building the resilience of intersex people through law. *Legal Studies* 38: 587–606.
27. Garland F, Travis M (2020) Making the state responsible: Intersex embodiment, medical jurisdiction, and state responsibility. *Journal of Law and Society* 47(2): 298–324.
28. Ghattas D (2013) *Human Rights between the Sexes: A Preliminary Study on the Life Situations of Inter* Individuals*. Berlin: Heinrich-Boll-Stiftung.
29. Ghattas D (2019) Protecting Intersex People in Europe: A Toolkit for Law and Policymakers. Available at: https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2019/05/Protecting_intersex_in_Europe_toolkit.pdf (accessed 12 May 2021).
30. Henry, E., Awondo, P., Fugon, L., et al. (2012) Coming Out of the Nkuta: Disclosure of Sexual Orientation Associated with Reduced Risk Behavior among MSM in Cameroon. Archives of Sexual Behavior, 41, 525-527. https://doi.org/10.1007/s10508-012-9916-8
31. IACHR (Inter-American Commission on Human Rights). 2015. *Violence against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Persons in the Americas*. Official Records. Washington, DC: OAS. Available online: https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ViolenceLGBTIPersons.pdf

(accessed on 10 January 2023).
32. Menguele Menyengue, A.M. (2016) Discourse religieux et homosexualité au Cameroun. Journal des Anthropologues, 146-147, 67-86. http://journals.openedition.org/jda/6494
33. Monro S, Crocetti D, Yeadon-Lee T (2019) Intersex/variations of sex characteristics and DSD citizenship in the UK, Italy and Switzerland. *Journal of Citizenship Studies* 23(8): 780–797.
34. Rubin DA (2017) *Intersex Matters: Biomedical Embodiment, Gender Recognition, and Transnational Activism*. Albany, NY: SUNY Press.
35. Rubin, David A. 2012. "An Unnamed Blank That Craved a Name": A Genealogy of Intersex as Gender. *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 37: 883–908. [Google Scholar] [CrossRef] [Green Version]
36. Rubin, David A. 2015. Provincializing Intersex: US Intersex Activism, Human Rights, and Transnational Body. *Frontiers: A Journal of Women Studies* 36: 51–83. [Google Scholar] [CrossRef]
37. Suen YT, Chan RCH, Badgett MVL (2021) The experiences of sexual and gender minorities in employment: Evidence from a large-scale survey of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people in China. *The China Quarterly (London)* 245: 142–164.
38. Viloria H, Nieto M (2020) *The Spectrum of Sex: The Science of Male, Female, and Intersex*. London: Jessica Kingsley Publications.
39. Ravesloot, Saskia. 2021. The Universal Periodic Review beyond the Binary Advancing the Rights of Persons with Variations in Sex Characteristics. Paper presented at 8th International Conference on Gender & Women Studies, Singapore, July 29; Available online: https://asianstudies.info/wp-content/uploads/2021/09/ProceedingsGWS2021.pdf#page=7 (accessed on 29 November 2022).
40. UN (United Nations). 1989. *Convention on the Rights of the Child*; General Assembly. New York: United Nations Treaty Series. Available online: https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html (accessed on 5 January 2023).
41. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2019. *Background Note on Human Rights Violations against Intersex People*. Geneva: OHCHR. Available online: https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/background-note-human-rights-violations-against-intersex-people (accessed on 10 January 2023).
42. United Nations, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2017. *Reporting to the United Nations Human Rights Treaty Bodies Training Guide. Part I*. Geneva: Manual. [Google Scholar]
43. https://www.journalducameroun.com/cameroun-un-bebe-hermaphrodite-met-sa-famille-dans-lembarras/ , https://www.sourds.net/2008/09/06/la-pathetique-histoire-de-kevin-qui-a-deux-sexes/, https://www.youtube.com/watch?v=Q3QeL8QHrpU.